

Noradrenaline inj.

4 mg/4ml, amp

ข้อมูลยา



วันที่ปรับปรุง : ม.ค. 67

โดย: คกก.พัฒนาระบบยา
รพ.กรุงปิ้ง

ข้อบ่งใช้ : รักษาภาวะ shock ในกรณีที่ให้สารน้ำเพียงพอแล้ว, severe hypotension

ขนาดยาเริ่มต้นและการบริหารยา :

เด็ก : Post-cardiac arrest = 0.05 – 0.1 mcg/kg/min

ผู้ใหญ่

- ขนาดยาเริ่มต้น : 8 – 12 mcg/min, maintenance dose: 2 – 4 mcg/min IV in fusion, titrate 0.03 mcg/kg/min q 2 นาที
- **Cardiogenic shock** : 0.05 – 0.4 mcg/kg/min IV infusion ใช้ความเข้มข้น 1:25 หรือ 1:62.5
- **Septic shock** : 0.01 – 3 mcg/kg/min IV infusion ให้ใช้ความเข้มข้น 1:62.5
- **Post cardiac arrest**: 0.1 – 0.5 mcg/kg/min

การผสมยา: ห้ามผสมกับ Sodium bicarbonate, alkaline solution (สารละลายด่าง), whole blood

Levophed (1:25) ==> 4 mg in D5W หรือ D5S 100 ml (40 mcg/ml)																		
Dose (mcg/min)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
	Low dose							Medium dose							High dose			
Rate (ml/hr)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
Levophed (1:62.5) ==> 1.6 mg (1.6 ml) in D5W หรือ D5S 100 ml (16 mcg/ml)																		
Dose (mcg/min)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
	Low dose							Medium dose							High dose			
Rate (ml/hr)	8	15	23	30	38	45	53	60	68	75	83	90	98	105	113	120	128	135

สารน้ำที่เข้ากัน

ได้: D5W,

D5S ห้ามผสม

ใน NSS เพราะ

จะทำให้ความ

แรงของยาลด

ลง

ความคงตัว: หลังจากเจือจางยาสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 24 ชั่วโมง ห้ามใช้สารละลายที่ขุ่นหรือเปลี่ยนสี (ชมพู เหลือง น้ำตาล)

การติดตาม :

- BP, HR ทุก 2 นาที เมื่อเริ่มให้ยา จน BP อยู่ในระดับที่ต้องการ หลังจากนั้นทุก 5 นาที ตลอดระยะเวลาการให้
- ตรวจดู IV site ทุก 1 ชม. ตลอดระยะเวลามีการให้ยา หากเกิด extravasation ให้ติดตามทุก 15 นาที
- การแก้ไข Extravasation : หยุดยาทันที และถอดอุปกรณ์ในการฉีดออก จากนั้นค่อยๆดูดยาที่ค้างออกมาให้มากที่สุด (ไม่ flush line) และประคบอุ่นครั้งละ 15 นาที วันละ 4 ครั้ง ยกแขนข้างที่เกิดให้สูง

แจ้งแพทย์เมื่อ :

- Adult : BP > 160/100 mmHg , HR > 120/min
- เด็ก : BP > 120/80, HR > 180 /min
- ผิวน้ำหรือเขียว
- Extravasation